



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

PANDUAN PRAKTIK KLINIS TAHUN 2025

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor 319.37/I-PND/DIR/IV/2025

Tentang
Panduan Praktik Klinis

Disusun oleh :
Penanggung Jawab TIM AKP



(Afni Nur Ainy, S.Kep., Ns)

Disetujui oleh :
Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M.Kes AFP)

Ditetapkan oleh :
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(dr. Nur Mazidah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Panduan Praktik Klinis dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan RS. Prima Husada. Panduan Praktik Klinis ini yang mulai dipergunakan pada tahun 2025 meliputi standar profesi, wewenang dan tanggung jawab dalam menjalani praktik di rumah sakit.

Kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Panduan Praktik Klinis ini, dapat meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit Prima Husada.

Malang, 04 April 2025
Direktur RS Prima Husada



dr. Nur Mazidah

TIM PENYUSUN
PANDUAN PRAKTIK KLNIS

Pengarah :

1. Dr. dr. Aslichah, M.Kes, AFP

Pelaksana :

1. dr. Nur Mazidah
2. Afni Nur Ainy, S.Kep., Ns
3. Ratih Aji Suryamanjari, S.Kep., Ns
4. Murwani Suryaning Sapartinah, A.Md. Kep
5. Ferianto Hendri Cahyono, AMd. Kep

DAFTAR ISI

SAMPUL

LEMBAR PENGESAHAN i

KATA PENGANTAR..... ii

TIM PENYUSUNiii

DAFTAR ISI..... iv

PERATURAN DIREKTUR v

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Maksud dan Tujuan2

 1.3 Ruang Lingkup2

 1.4 Pengertian3

BAB II STRUKTUR PENULISAN PANDUAN PRAKTIK KLINIS4

BAB III TATA LAKSANA.....6

BAB IV AUDIT DAN JAMINAN MUTU 7

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA
HUSADA NOMOR 319.37/I-PND/DIR/IV/2025**

**TENTANG
PANDUAN PRAKTIK KLINIS**

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan primer perlu disusun panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan primer;
- b. bahwa standar profesi dan standar pelayanan profesi dituangkan dalam bentuk panduan praktik klinis bagi dokter penanggung jawab pasien yang disusun oleh kelompok staf medis dan komite medik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Panduan Praktik Klinis;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar pelayanan kedokteran
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Paduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
9. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor: 263/DPM/I-KEP/DIR/I/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang
10. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 390/I-KEP/DIR/V/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG PANDUAN PRAKTIK KLINIS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Rumah Sakit ini yang dimaksud dengan:

- (1) Panduan Praktik Klinis (PPK) atau clinical practice guidelines merupakan pernyataan (acuan, statement) yang sistematis yang membantu para praksi dan pasien memilih asuhan yang tepat untuk suatu kondisi klinis tertentu (misalnya, rekomendasi dalam manajemen kasus diare pada anak dibawah 5 tahun). Praktisi tersebut dipandu dengan semua tahapan konsultasi (pertanyaan yang harus disampaikan, tanda fisik yang harus dicari, pemeriksaan laboratorium yang harus diminta, penilaian keadaan, dan pengobatan yang harus diresepkan).
- (2) Panduan Praktik Klinis meliputi pedoman penatalaksanaan terhadap penyakit yang dijumpai di rumah sakit berdasarkan kriteria:
 - a. penyakit yang prevalensinya cukup tinggi;
 - b. penyakit dengan risiko tinggi; dan
 - c. penyakit yang membutuhkan pembiayaan tinggi.

BAB II Profesiona Pemberi Asuhan (PPA)

Pasal 2

- (1) Profesional pemberi asuhan (PPA) bekerja sebagai tim interdisiplin dengan kolaborasi interprofesional dibantu antara lain oleh Panduan Praktik Klinis (PPK), Panduan Asuhan Profesional Pemberi Asuhan (PPA) lainnya, Alur Klinis/ Pathway terintegrasi, Algoritme, Protokol, Prosedur, *Clinical Pathway* dan CPPT (Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi);

Pasal 3

- (1) Asuhan bagi pasien risiko tinggi tersebut didukung oleh penggunaan PPK, regulasi lainnya dan rencana asuhan.

Pasal 4

- (1) SPO disusun oleh staf medis pada fasilitas pelayanankesehatan yang dikoordinasi oleh Komite Medis dan ditetapkan oleh Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) SPO harus selalu ditinjau kembali dan diperbaharui sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran atau kedokteran gigi.

Pasal 5

- (1) Dokter dan dokter gigi serta tenaga kesehatan lainnya di fasilitas pelayanan kesehatan harus mematuhi PNPK dan SPO sesuai dengan keputusan klinis yang diambilnya.

- (2) Kepatuhan kepada PNPK dan SPO menjamin pemberian pelayanan kesehatan dengan upaya terbaik di fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi tidak menjamin keberhasilan upaya atau kesembuhan pasien;
- (3) Modifikasi terhadap PNPK dan SPO hanya dapat dilakukan atas dasar keadaan yang memaksa untuk kepentingan pasien, antara lain keadaan khusus pasien, kedaruratan, dan keterbatasan sumber daya.
- (4) Modifikasi PNPK dan SPO sebagaimana dimaksud pada ayat
- (5) harus dicatat di dalam rekam medis.

Pasal 6

- (1) Tindakan sedasi (moderat dan dalam) baik cara memberikan dan menataui berdasarkan panduan praktik klinis.
- (2) Status fisiologis dimonitor selama proses anestesi dan bedah sesuai dengan panduan praktik klinis serta di dokumentasikan dalam forma anestesi.

Pasal 7

- (1) Evaluasi pelayanan kedokteran dengan panduan praktik klinis, alur klinis, dan protokol.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 04 April 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



dr. Nur Mazidah

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH
SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR 319.37/I-PND/DIR/IV/2025
TENTANG
PANDUAN PRAKTIK KLINIS

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Ketua Kelompok Staf Medis telah menetapkan paling sedikit 5 (lima) prioritas panduan praktik klinis-alur klinis dan/atau protokol klinis dan atau prosedur dan/atau sebagai panduan standarisasi proses asuhan klinis yang dimonitor oleh Komite Medik dengan tujuan sebagai berikut:

1. Melakukan standarisasi proses asuhan klinis;
2. Mengurangi risiko dalam proses asuhan terutama yang berkaitan asuhan kritis;
3. Memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan efisien dalam memberikan asuhan klinis tepat waktu dan efektif;
4. Memanfaatkan indikator prioritas sebagai indikator dalam penilaian kepatuhan penerapan alur klinis di area yang akan diperbaiki di tingkat rumah sakit;
5. Secara konsisten menggunakan praktik berbasis bukti (*"evidence based practices"*) dalam memberikan asuhan bermutu tinggi.

Penerapan panduan praktik klinis-*clinical pathway* dipilih oleh tiap-tiap kelompok staf medis adalah di unit-unit pelayanan di tempat DPJP memberikan asuhan. Mengacu pada prioritas pengukuran mutu pelayanan klinis yang akan dievaluasi maka selain ditetapkan indikator mutu, juga diperlukan standarisasi proses asuhan klinis pada prioritas pengukuran mutu di rumah sakit.

Karena itu, pimpinan medis bersama-sama dengan komite medis dan kelompok staf medis agar memilih dan menetapkan 5 (lima) panduan praktik klinis, alur klinis (*Clinical Pathway*), dan/atau protokol klinis, dan/atau prosedur, dan/atau *standing order* yang dipergunakan untuk pengukuran mutu prioritas rumah sakit dengan mengacu pada panduan praktik klinis dan alur klinis yang sudah diterapkan oleh kelompok staf medis di unit-unit pelayanan.

Evaluasi dapat dilakukan melalui audit medis dan atau audit klinis untuk menilai efektivitas penerapan panduan praktik klinis dan alur klinis sehingga dapat dibuktikan bahwa penggunaan panduan praktik klinis serta alur klinis telah mengurangi variasi proses dan hasil. Indikator area klinis (IAK), indikator area manajemen (IAM), dan indikator sasaran keselamatan pasien (ISKP) dapat digunakan sebagai indikator audit medis dan atau audit klinis, misalnya kepatuhan terhadap obat, pemeriksaan penunjang dan lama hari rawat (LOS).

Sesuai peraturan perundangan panduan praktik klinis (PPK) adalah istilah teknis sebagai pengganti standar prosedur operasional (SPO) yang merupakan istilah administratif. Penggantian ini perlu untuk menghindarkan kesalahpahaman yang mungkin terjadi bahwa "standar" merupakan hal yang harus dilakukan pada semua

keadaan. Jadi secara teknis SPO dibuat berupa PPK yang dapat berupa atau disertai dengan salah satu atau lebih: alur klinis (*Clinical pathway*), protokol, prosedur, algoritme, dan *standing order*.

Dalam PPK mungkin terdapat hal-hal yang memerlukan rincian langkah demi langkah. Untuk ini, sesuai dengan karakteristik permasalahan serta kebutuhan dapat dibuat (alur klinis), algoritme, protokol, prosedur, maupun *standing order*.

Contoh:

- a. Dalam PPK dinyatakan bahwa tata laksana stroke non hemoragik harus dilakukan secara mul disiplin dan dengan pemeriksaan serta intervensi dari hari ke hari dengan urutan tertentu. Karakteristik penyakit stroke nonhemoragik sesuai untuk dibuat alur klinis (*Clinical Pathway*, CP) sehingga perlu dibuat CP untuk stroke nonhemoragik.
- b. Dalam PPK dinyatakan bahwa pada pasien gagal ginjal kronik perlu dilakukan hemodialisis. Uraian rinci tentang hemodialisis dimuat dalam protokol hemodialisis pada dokumen terpisah.
- c. Dalam PPK dinyatakan bahwa pada anak dengan kejang demam kompleks perlu dilakukan pungsi lumbal. Uraian pelaksanaan pungsi lumbal dak dimuat dalam PPK melainkan dalam prosedur pungsi lumbal dalam dokumen terpisah.
- d. Dalam tata laksana kejang demam diperlukan pemberian diazepam rektal dengan dosis tertentu yang harus diberikan oleh perawat bila dokter tidak ada, hal ini diatur dalam "*standing order*".

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud disusunnya Panduan Praktik Klinis adalah untuk digunakan sebagai panduan atau acuan bagi para Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) dalam memberikan asuhan medis.

2. Tujuan

Panduan Praktik Klinis bertujuan untuk memberikan acuan bagi dokter dalam memberikan pelayanan di rumah sakit dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan sekaligus menurunkan angka rujukan, memberikan jaminan kepada pasien untuk memperoleh pelayanan kedokteran yang berdasarkan pada nilai ilmiah sesuai dengan kebutuhan medis pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kedokteran yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi

1.3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Panduan Praktik Klinis (PPK) ini meliputi pedoman penatalaksanaan terhadap penyakit yang dijumpai di rumah sakit. Jenis penyakit mengacu pada Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia.

Pemilihan penyakit pada PPK ini berdasarkan kriteria:

1. Penyakit yang prevalensinya cukup tinggi
2. Penyakit dengan risiko tinggi
3. Penyakit yang membutuhkan pembiayaan tinggi.

1.4 PENGERTIAN

1. Standar Pelayanan Kedokteran adalah pedoman yang harus diikuti oleh dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran.
2. Standar Prosedur Operasional, selanjutnya disingkat SPO adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu, atau langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama dalam melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi.
3. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Strata Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tingkatan pelayanan yang standar tenaga dan peralatannya sesuai dengan kemampuan yang diberikan.
5. Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
6. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk praktik kedokteran atau kedokteran gigi.
7. Kondisi adalah gambaran klinis yang berupa gejala dan/atau tanda yang tampak pada pasien.
8. Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia beserta Perhimpunan Dokter Spesialis untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia beserta Perhimpunan Dokter Gigi Spesialis untuk dokter gigi.

BAB II

STRUKTUR PENULISAN PANDUAN PRAKTIK KLINIS

Panduan ini memuat pengelolaan penyakit mulai dari penjelasan hingga penatalaksanaan penyakit tersebut. Panduan Praktik Klinis (PPK) disusun berdasarkan pedoman yang berlaku secara global yang dirumuskan bersama ketua SMF dan Komite Medik RS. Prima Husada

Sistematika PPK:

1. Judul Penyakit

Berdasarkan daftar penyakit terpilih di SKDI 2012, namun beberapa penyakit dengan karakteristik yang hampir sama dikelompokkan menjadi satu judul penyakit.

Kode Penyakit, dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut :

a. Kode International Classification of Primary Care (ICPC) 2

Kodifikasi yang dirancang khusus untuk fasilitas pelayanan primer. Kode disusun berdasarkan atas alasan kedatangan, diagnosis dan penatalaksanaan. Alasan kedatangan dapat berupa keluhan, gejala, masalah kesehatan, tindakan maupun temuan klinik.

b. Kode International Classification of Diseases (ICD) 10

Merupakan kodifikasi yang dirancang untuk rumah sakit. Kodifikasi dalam bentuk nomenklatur berdasarkan sistem tubuh, etiologi, dan lain-lain.

Tingkat kompetensi berdasarkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.

Nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia.

2. Masalah Kesehatan

Masalah kesehatan berisi pengertian singkat serta prevalensi penyakit di RS. Prima Husada. Substansi dari bagian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan awal serta gambaran kondisi yang mengarah kepada penegakan diagnosis penyakit tersebut.

3. Hasil Anamnesis (Subjective)

Hasil Anamnesis berisi keluhan utama maupun keluhan penyerta yang sering disampaikan oleh pasien atau keluarga pasien. Penelusuran riwayat penyakit yang diderita saat ini, penyakit lainnya yang merupakan faktor risiko, riwayat keluarga, riwayat sosial, dan riwayat alergi menjadi informasi lainnya pada bagian ini. Pada beberapa penyakit, bagian ini memuat informasi spesifik yang harus diperoleh dokter dari pasien atau keluarga pasien untuk menguatkan diagnosis penyakit.

4. Hasil Pemeriksaan Fisik dan Pemeriksaan Penunjang Sederhana (Objective)

Bagian ini berisi hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang yang spesifik, mengarah kepada diagnosis penyakit (pathognomonis). Meskipun tidak memuat rangkaian pemeriksaan fisik lainnya, pemeriksaan tanda vital dan pemeriksaan fisik menyeluruh tetap harus dilakukan oleh dokter untuk memastikan diagnosis serta menyingkirkan diagnosis banding.

5. Penegakan Diagnosis (Assessment)

Bagian ini berisi diagnosis yang sebagian besar dapat ditegakkan dengan anamnesis, dan pemeriksaan fisik. Beberapa penyakit membutuhkan hasil pemeriksaan penunjang untuk memastikan diagnosis atau karena telah menjadi standar algoritma penegakkan diagnosis. Selain itu, bagian ini juga memuat klasifikasi penyakit, diagnosis banding, dan komplikasi penyakit.

6. Rencana Penatalaksanaan Komprehensif (Plan)

Bagian ini berisi sistematika rencana penatalaksanaan berorientasi pada pasien (patient centered) yang terbagi atas dua bagian yaitu penatalaksanaan non farmakologi dan farmakologi. Selain itu, bagian ini juga berisi edukasi dan konseling terhadap pasien dan keluarga (family focus), aspek komunitas lainnya (community oriented) serta kapan dokter perlu merujuk pasien (kriteria rujukan).

Dokter akan merujuk pasien apabila memenuhi salah satu dari kriteria "TACC" (Time-Age-Complication-Comorbidity) berikut

- Time : jika perjalanan penyakit dapat digolongkan kepada kondisi kronis atau melewati GoldenTime Standard.
- Age : jika usia pasien masuk dalam kategori yang dikhawatirkan meningkatkan risiko komplikasi serta risiko kondisi penyakit lebih berat.
- Complication : jika komplikasi yang ditemui dapat memperberat kondisi pasien
- Comorbidity : jika terdapat keluhan atau gejala penyakit lain yang memperberat kondisi pasien.

Selain empat kriteria di atas, kondisi fasilitas pelayanan juga dapat menjadi dasar bagi dokter untuk melakukan rujukan demi menjamin keberlangsungan penatalaksanaan dengan persetujuan pasien.

7. Sarana Prasarana

Bagian ini berisi komponen fasilitas pendukung spesifik dalam penegakkan diagnosis dan penatalaksanaan penyakit tersebut. Penyediaan sarana prasarana tersebut merupakan kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan.

8. Kriteria Pulang

Merupakan indikator klinis untuk menentukan waktu kepulangan pasien. Bisa menjadi sasaran rencana terapi selama perawatan.

9. Prognosis

Kategori prognosis sebagai berikut :

1. Ad vitam, menunjuk pada pengaruh penyakit terhadap proses kehidupan.
2. Ad functionam, menunjuk pada pengaruh penyakit terhadap fungsi organ atau fungsi manusia dalam melakukan tugasnya.
3. Ad sanationam, menunjuk pada penyakit yang dapat sembuh total sehingga dapat beraktivitas seperti biasa.

Prognosis digolongkan sebagai berikut:

1. Sanam : sembuh
2. Bonam : baik
3. Malam : buruk/jelek
4. Dubia : tidak tentu/ragu-ragu. Dubia ad sanam : tidak tentu/ragu-ragu, cenderung sembuh/baik. Dubia ad malam : tidak tentu/ragu-ragu, cenderung memburuk/jelek

Untuk penentuan prognosis sangat ditentukan dengan kondisi pasien saat diagnosis ditegakkan.

BAB III

TATA LAKSANA

Penerapan konsep pelayanan berfokus pada pasien adalah dalam bentuk Asuhan Pasien Terintegrasi yang bersifat integrasi horizontal dan vertikal dengan elemen:

1. Dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) sebagai ketua tim asuhan / *Clinical Pathway*
2. Profesional Pemberi Asuhan bekerja sebagai tim intra- dan inter-disiplin dengan kolaborasi interprofesional, dibantu antara lain dengan Panduan Praktik Klinis (PPK), Panduan Asuhan PPA lainnya, Alur Klinis/ *Clinical Pathway* terintegrasi, Algoritme, Protokol, Prosedur, *Standing Order* dan CPPT (Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi)
3. Manajer Pelayanan Pasien/ Case Manager
4. Keterlibatan dan pemberdayaan pasien dan keluarga

Pelaksanaan Asuhan Pasien Terintegrasi pusatnya adalah pasien dan mencakup elemen antara lain sebagai berikut:

- a. Keterlibatan dan pemberdayaan pasien dan keluarga.
- b. DPJP sebagai Ketua Tim PPA (*Clinical Team Leader*)
- c. PPA bekerja sebagai tim interdisiplin dengan kolaborasi interprofesional, antara lain memakai Panduan Praktik Klinis (PPK), Panduan Asuhan PPA lainnya disertai alur Klinis terintegrasi *integrated clinical pathway*, dan Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi/CPPT;
- d. Perencanaan Pemulangan Pasien *Discharge Planning* terintegrasi;
- e. Asuhan Gizi Terintegrasi;
- f. Manajer Pelayanan Pasien/ *Case Manager*.

Pendokumentasian di rekam medis merupakan alat untuk memfasilitasi dan menggambarkan integrasi serta koordinasi asuhan. Secara khusus, setiap PPA mencatat observasi dan pengobatan di rekam medis pasien. Demikian juga, setiap hasil atau simpulan dari rapat tim atau diskusi pasien dicatat dlm CPPT.

Asuhan pasien yang seragam terrefleksi sebagai berikut:

- a) akses untuk asuhan dan pengobatan yang memadai dan diberikan oleh PPA yang kompeten tidak bergantung pada hari setiap minggu atau waktunya setiap hari ("3-24-7");
- b) penggunaan alokasi sumber daya yang sama, antara lain staf klinis dan pemeriksaan diagnostik untuk memenuhi kebutuhan pasien pada populasi yang sama;
- c) pemberian asuhan yang diberikan kepada pasien, contoh pelayanan anestesi sama di semua unit pelayanan di rumah sakit;
- d) pasien dengan kebutuhan asuhan keperawatan yang sama menerima asuhan keperawatan yang setara di seluruh rumah sakit;
- e) penerapan serta penggunaan regulasi dan form dalam bidang klinis antara lain metode asesmen IAR (Informasi, Analisis, Rencana), form asesmen awal-asesmen ulang, panduan praktik klinis (PPK), alur klinis terintegrasi/ *integrated clinical pathway*, pedoman manajemen nyeri, dan regulasi untuk berbagai tindakan antara lain *water sealed drainage*, pemberian transfusi darah, biopsi ginjal, pungsi lumbal, dsb.

BAB IV

AUDIT DAN JAMINAN MUTU

Proses monitor dan evaluasi berkelanjutan dimaksudkan untuk:

1. Meningkatkan praktik individual terkait mutu dan asuhan pasien yang aman;
2. Digunakan sebagai dasar mengurangi variasi di dalam KSM (kelompok staf medis)/ unit layanan dengan cara membandingkan antara kolega, penyusunan PPK (panduan praktik klinis), dan
3. Digunakan sebagai dasar memperbaiki kinerja kelompok staf medis/unit layanan dengan cara membandingkan acuan praktik di luar rumah sakit, publikasi riset, dan indikator kinerja klinis nasional bila tersedia.
4. Penilaian kinerja staf medis berkelanjutan setiap tahun yang dikeluarkan oleh rumah sakit yang berisi jumlah pasien per penyakit/tindakan yang ditangani per tahun, rerata lama dirawat, serta angka kematiannya. Angka ILO dan kepatuhan terhadap PPK meliputi penggunaan obat, penunjang diagnostik, darah, produk darah, dan lainnya;
5. Rumah Sakit Prima Husada bertanggung jawab untuk menjaga berlangsungnya proses pengukuran kepatuhan pelaksanaan PPK-CP dengan menggunakan protokol standar Rumah Sakit Prima Husada
6. Data audit akan ditinjau ulang secara teratur oleh Rumah Sakit Prima Husada

Malang, 04 April 2025

Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



dr. Nur mazidah